Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
Vara Estadual da Saúde Pública

Rua Manoelito de Ornelas, 50 - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90110230 - Fone: (51) 3210-6500 - Email: frpoacentvesp@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5221325-60.2024.8.21.0001/RS

AUTOR: LORI MARQUES BONES

RÉU: IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

LORI MARQUES BONES ajuizou ação ordinária em face do IPE-SAÚDE alegando possuir diagnóstico de **mielofibrose pós-trombocitose essencial (CID10-D47.1)** e que, em razão disso, necessita fazer uso do medicamento **Ruxolitinibe 20 mg**. Requereu a procedência da demanda, a fim de que seja fornecida a medicação postulada (evento 1, INIC1).

Indeferida a gratuidade da justiça (evento 10, DESPADEC1), a parte autora efetuou o pagamento da primeira parcela (evento 21, CUSTAS2).

Deferida a tutela de urgência (evento 28, DESPADEC1).

O IPE-SAÚDE informou a autorização administrativa para o tratamento com o fármaco postulado (evento 34, OFIC1).

Citado, o réu contestou, alegando, em síntese, que não pode admitir, nem ser compelido à cobertura de um tratamento que excede o previsto por seu regulamento, de custo elevado, sob pena de ser levado à insolvência, prejudicando a coletividade associada. Requereu a improcedência da ação (evento 42, CONT1).

A parte autora apresentou réplica (evento 46, RÉPLICA1).

Instadas as partes sobre eventual interesse na dilação probatória (evento 49, DESPADEC1), a parte autora produziu prova documental (evento 54, PET1) e o demandado nada requereu (evento 56, PET1).

O Ministério Público opinou pela procedência da demanda (evento 59, PROMOÇÃO1).

É o relatório.

Passo a fundamentar.

I. DO MÉRITO

I.1. Do Direito à Saúde

Destaca-se, de início, que a Constituição Federal, em seu art. 5º, *caput*, ao tratar dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, garantiu o direito à vida e em seu art. 6º, *caput*, que cuida dos direitos sociais, assegurou o direito à saúde, dentre outros. Não bastasse isso, o art. 196, que trata da ordem social, prescreveu o direito à saúde de forma circunstanciada.

A Constituição Estadual do Rio Grande do Sul, no mesmo sentido, em seu art. 241, preceitua que a saúde é um direito de todos.

I.2. Da necessidade do tratamento

No caso em análise, a tutela de urgência foi deferida, a qual abaixo colaciono e passo a ratificar (evento 28, DESPADEC1):

> *Segundo o laudo médico acostado aos autos, a parte autora apresenta o diagnóstico de **Mielofibrose Pós-Trombocitose Essencial (CID 10 D47.1),** necessitando fazer uso do medicamento **Ruxolitinibe 20 mg.** Ressaltou a **urgência** do tratamento, visto que com a utilização do fármaco proporcionará melhora na qualidade de vida e melhora dos sintomas do autor (evento 1, LAUDO6):*
>
> *[...]*
>
> *A nota técnica, por sua vez, sobreveio com **conclusão favorável** ao tratamento requerido (evento 26, NOTATEC1):*
>
> *[...]*
>
> *Ademais, foi juntada ao feito a negativa administrativa do IPE-SAÚDE (evento 1, OUT9).*
>
> *Vale dizer, restando comprovado que a parte autora necessita submeter-se ao tratamento postulado, não há razão para a negativa do IPE-SAÚDE, a quem incumbe assegurar o tratamento e a intervenção mais adequados para o trato da sua enfermidade.*

Importante aduzir, ainda, que a parte autora mantém contrato firmado com o Instituto, contribuindo para o referido plano de saúde, o qual deve lhe garantir acesso amplo e seguro à assistência à saúde.

Por fim, ressalto que, embora este juízo não desconheça que a Lei Complementar nº 15.145/18 excluiu o fornecimento dos tratamentos não previstos nas tabelas do instituto (artigo 4º, §1º), é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que cabe ao plano de saúde prever as enfermidades as quais será fornecida a cobertura de tratamento, entretanto não é facultado ao plano escolher quais tratamentos serão dispensados. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE TRATAMENTO A DOENÇA COBERTA. ÍNDOLE ABUSIVA. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, AINDA QUE IMPLÍCITO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento consolidado nesta Corte, é possível o reconhecimento de prequestionamento implícito, para fins de conhecimento do recurso especial, quando as questões debatidas no recurso especial tenham sido decididas no acórdão recorrido, ainda que sem a explícita indicação dos dispositivos de lei que o fundamentaram. In casu, a questão atinente ao valor atribuído na origem às astreintes não foi debatida nem decidida no acórdão de origem, não tendo sido prequestionado o art. 461, § 6º, do CPC/73. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. "A jurisprudência desta Corte reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico" (AgInt no AREsp 949.765/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 1º/12/2016, DJe de 19/12/2016). 3. Agravo interno não provido.

Dessa forma, comprovados a probabilidade do direito e a urgência consistente no perigo de dano, tenho, em cognição sumária, que é caso de deferimento da tutela de urgência.

*Ante o exposto, **DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA** para determinar ao IPE-SAÚDE que, no prazo de 05 (cinco) dias, passe a disponibilizar à parte autora o medicamento **Ruxolitinibe 20 mg**, nos termos da prescrição médica, pelo tempo necessário à realização do seu tratamento.*

A necessidade resta evidenciada pela documentação médica acostada aos autos (evento 1, LAUDO6), que indica possuir a parte autora diagnóstico de **mielofibrose pós-trombocitose essencial (CID10-D47.1)** e que, em razão disso, é imprescindível o uso do medicamento **Ruxolitinibe 20 mg**. Da mesma forma, comprovada a urgência do tratamento. Senão vejamos:

CREMERS
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AUTARQUIA FEDERAL

PACIENTE

Lori Marques Bones CPF: 154.490.760-53

Atestado Médico

Laudo Médico

O paciente Lori Marques Bones, 83 anos, foi diagnosticado em 2016 com trombocitemia essencial (CID D75.2), sendo iniciado hidroxiuréia para controle dos níveis plaquetários, apresentando bom controle das plaquetas; porém, nos últimos 12 meses, paciente vem apresentando importante astenia, inapetência e emagrecimento, LDH elevado, sendo realizado nova biópsia de medula óssea que demonstrou progressão para mielofibrose, com indicação de uso de ruxolitinib (nome comercial: JAKAVI) para controle dos sintomas constitucionais. A mielofibrose é uma doença mieloproliferativa crônica que não expressa mutação do Bcr-Abl, caracterizando-se por formação de fibrose medular que ocasionam sintomas como citopenias, esplenomegalia, que muitas vezes é dolorosa, além de astenia importante e sintomas constitucionais (febre, emagrecimento, inapetência, sudorese noturna, fraqueza) que comprometem de forma significativa a qualidade de vida. Além disso, pode haver progressão para leucemia mieloide aguda (LMA). As doenças mieloproliferativas crônicas Bcr-Abl negativo, como no caso da mielofibrose, trombocitemia/trombocitose essencial e policitemia vera são caracterizadas por proliferação hematopoiética anormal que surgem das vias de transdução de sinais causadas por rearranjos genéticos ou mutações, como no caso da mutação p.Val617Phe no gene JAK2 (JAKV617F). A Janus-activated kinase (JAK) é uma família de proteínas com atividade tirosino-kinase localizadas no domínio intracelular de receptores de citocinas e de fatores de crescimento, sendo composta por quatro membros (JAK1, JAK2, JAK3 e tirosina-kinase 2), envolvidos na transdução dos sinais mediados por citocinas pela via sinalizadora JAK/STAT, regulando, por meios específicos, a hematopoiese, a imunidade, a inflamação e o crescimento celular. O ruxolitinib é um inibidor da via JAK/STAT, via que é acometida no desenvolvimento das síndromes mieloproliferativas, tendo atividade tanto para mielofibrose primária como para mielofibrose secundária (mielofibrose pós-Policitemia Vera ou pós-Trombocitose essencial), independentemente de terem mutação do JAK2 detectada, demonstrando superioridade, em comparação ao placebo ou à melhor terapia convencional disponível no tratamento da mielofibrose primária ou da mielofibrose secundária (pós-Policitemia Vera ou pós-Trombocitose essencial), proporcionando melhora dos sintomas constitucionais, melhora na qualidade de vida e melhora na sobrevida global, com respostas com duração mediana um pouco superior a 3 anos. No estudo COMFORT 1, pacientes forma randomizados para tratamento com ruxolitinib ou placebo. Comparado ao placebo, o ruxolitinib em 24 semanas, foi mais eficaz na redução do volume do baço (houve redução = 35% no volume do baço), com significância estatística (41,9% versus 0,7% no grupo placebo; p<0,0001), de forma que 67% dos indivíduos seguiam apresentando resposta sustentada em 48 semanas ou mais. Também foi identificada melhora da >50% ou mais na pontuação total dos sintomas constitucionais na 24ª semana de tratamento em 45% dos pacientes tratados com ruxolitinib versus 5,3% dos que receberam placebo (OR=15,3 com IC de 95%: 6,9 a 33,7). No estudo COMFORT II, foi feita comparação do uso de ruxolitinib versus a melhor terapia disponível (hidroxiuréia foi a melhor terapia disponível em metade dos pacientes). Nesse estudo, também foi evidenciado uma redução de = 35% no volume do baço em 48 semanas (28% x 0%, p<0,0001). Além disso, também houve melhora da qualidade de vida nestes pacientes.
Desta forma, solicito deferimento para o uso de ruxolitinib para tratamento de mielofibrose secundária à trombocitemia essencial para melhora dos sintomas constitucionais, uma vez que é indicado no tratamento de primeira linha da mielofibrose primária ou secundária.

Bibliografia:
- Baxter EJ, Scott LM, Campbell PJ, East C, Fourouclas N, Swanton S, Vassiliou GS, Bench AJ, Boyd EM, Curtin N, Scott MA, Erber WN, Green AR; Cancer Genome Project. Acquired mutation of the tyrosine kinase JAK2 in human myeloproliferative disorders. Lancet. 2005;365(9464):1054-61. Erratum in: Lancet. 2005;366(9480):122. PubMed PMID: 15781101.

- Verstovsek S, Kantarjian H, Mesa RA, Pardanani AD, Cortes-Franco J, Thomas DA, Estrov Z,

Este documento foi emitido e assinado digitalmente por BIANCA FERNANDES SARTURI 34260/RS através do sistema ESPACO MEDICO do CREMERS em 26/08/2024 18:

Fridman JS, Bradley EC, Erickson-Viitanen S, Vaddi K, Levy R, Tefferi A. Safety and efficacy of INCB018424, a JAK1 and JAK2 inhibitor, in myelofibrosis. N Engl J Med. 2010;363(12):1117-27. PubMed PMID: 20843246.

- Verstovsek S, Mesa RA, Gotlib J, Levy RS, Gupta V, DiPersio JF, Catalano JV, Deininger M, Miller C, Silver RT, Talpaz M, Winton EF,Harvey JH Jr, Arcasoy MO, Hexner E, Lyons RM, Paquette R, Raza A, Vaddi K, Erickson-Viitanen S, Koumenis IL, Sun W, Sandor V, Kantarjian HM. A double-blind, placebo-controlled trial of ruxolitinib for myelofibrosis. N Engl J Med. 2012;366(9):799-807. PubMed PMID: 22375971

- Harrison C, Kiladjian JJ, Al-Ali HK, Gisslinger H, Waltzman R, Stalbovskaya V, McQuitty M, Hunter DS, Levy R, Knoops L, Cervantes F, Vannucchi AM, Barbui T, Barosi G. JAK inhibition with ruxolitinib versus best available therapy for myelofibrosis. N Engl J Med. 2012;366(9):787-98. PubMed PMID: 22375970.

- Srdan Verstovsek, Ruben A. Mesa, Jason Gotlib, Vikas Gupta, John F. DiPersio, John V. Catalano, Michael W. N. Deininger, Carole B. Miller, Richard T. Silver, Moshe Talpaz, Elliott F. Winton, Jimmie H. Harvey, Jr.,Murat O. Arcasoy, Elizabeth O. Hexner, Roger M. Lyons, Ronald Paquette, Azra Raza, Mark Jones, Deanna Kornacki, Kang Sun, Hagop Kantarjian, and for the COMFORT-I investigators. Long-term treatment with ruxolitinib for patients with myelofibrosis: 5-year update from the randomized, double-blind, placebo-controlled, phase 3 COMFORT-I trial.) J Hematol Oncol. 2017; 10: 55. Published online 2017 Feb 22. doi: 10.1186/s13045-017-0417-z

- Harrison CN, Mesa RA, Kiladjian JJ, Al-Ali HK, Gisslinger H, Knoops L, Squier M, Sirulnik A, Mendelson E, Zhou X, Copley-Merriman C, Hunter DS, Levy RS, Cervantes F, Passamonti F, Barbui T, Barosi G, Vannucchi AM. Health-related quality of life and symptoms in patients with myelofibrosis treated with ruxolitinib versus best available therapy. Br J Haematol. 2013;162(2):229-39. PubMed PMID: 23672349.

- N Harrison, A M Vannucchi, J-J Kiladjian, H K Al-Ali, H Gisslinger, L Knoops, F Cervantes, M M Jones, K Sun, M McQuitty, V Stalbovskaya, P Gopalakrishna and T Barbui, on behalf of the COMFORT-II Investigators. Long-term findings from COMFORT-II, a phase 3 study ofruxolitinib vs best available therapy for myelofibrosis.) Leukemia. 2016 Aug; 30(8): 1701-1707.Published online 2016 Jun 17.

26 de Agosto de 2024

BIANCA FERNANDES SARTURI CRM-RS: 34261

Clínica Médica (RQE: 28507), Hematologia E Hemoterapia (RQE: 28508)

Endereço Comercial: R OLAVO BILAC 805, BAIRRO SANTANA, PORTO ALEGRE - RS

ICP Brasil

Atestado emitido no dia 26/08/2024 18:25:06 por BIANCA FERNANDES SARTURI - 34261/RS para Lori Marques Bones (CPF: 154.490.760-53 evanice.te@hotmail.com).

Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do CREMERS, na Internet, no endereço: **https://servicos.cremers.org.br/crvirtual-prescricao/#/validador/atestado/WbH8XFsn** ou diretamente em um dispositivo móvel com leitor de QRCODE.

Ainda, o laudo médico atualizado indica que o paciente apresentou boa resposta ao uso da medicação pleiteada e que é necessária a manutenção do tratamento por tempo indeterminado (evento 54, LAUDO2):

CREMERS

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AUTARQUIA FEDERAL

PACIENTE

Lori Marques Bones CPF: 154.490.760-53

Atestado Médico

Laudo Médico

O paciente Lori Marques Bones iniciou com ruxolitinib (JAKAVI) em novembro de 2024 para tratamento de mielofibrose secundária a trombocitemia essencial prévia. Paciente com importante melhora sintomática da astenia, das dores ósseas e do apetite após o início do JAKAVI, conseguindo engordar 7kg em 3 meses. Paciente deve manter o uso de ruxolitinib por tempo indeterminado (enquanto apresentar bom controle dos sintomas).
O Jakavi é indicado para o tratamento de pacientes com mielofibrose, conforme indicado em BULA APROVADA PELA ANVISA EM 21/02/2022.

25 de Fevereiro de 2025

BIANCA FERNANDES SARTURI CRM-RS: 34261

Clínica Médica (RQE: 28507), Hematologia E Hemoterapia (RQE: 28508)

Endereço Comercial: R OLAVO BILAC 805, BAIRRO SANTANA, PORTO ALEGRE - RS

ICP Brasil

Atestado emitido no dia 25/02/2025 09:56:39 por BIANCA FERNANDES SARTURI - 34261/RS para Lori Marques Bones (CPF: 154.490.760-53 evanice.te@hotmail.com).

Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do CREMERS, na Internet, no endereço: **https://servicos.cremers.org.br/crvirtual-prescricao/#/validador/atestado/bgT42PDH** ou diretamente em um dispositivo móvel com leitor de QRCODE.

Este documento foi emitido e assinado digitalmente por BIANCA FERNANDES SARTURI 34261/RS através do sistema ESPACO MEDICO do CREMERS em 25/02/2025 09:

Com efeito, a médica assistente é quem detém a melhor capacidade para indicar os medicamentos com melhor eficácia para o tratamento da parte autora.

A assistência à saúde prestada pelo IPE-Saúde está submetida ao regime de direito público e deve seguir as regras definidas na Lei Complementar nº 15.145/2018 e os atos normativos da autarquia estadual, o que afasta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso concreto.

Em 06.04.2018, entrou em vigor a Lei Complementar nº 15.145/2018, que dispõe sobre a reestruturação do Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul – Sistema IPE-Saúde, revogando a Lei Complementar nº 12.134/2004 e excluindo da cobertura do IPE-Saúde os procedimentos, exames, tratamentos, insumos,

materiais e medicamentos que não estejam previstos nas tabelas próprias do Instituto (art. 4º, § 1º).

Destarte, comprovado que a parte autora necessita submeter-se ao tratamento preconizado pela médica assistente, não há razão para a negativa do IPE-Saúde, a quem incumbe assegurar o tratamento e a intervenção mais adequados para o trato da sua enfermidade. Para tanto, seria necessário que o Instituto requerido expusesse de forma clara e específica a justificativa técnica médica para o indeferimento do tratamento postulado.

Importante aduzir que a parte autora mantém contrato firmado com o Instituto, contribuindo para o referido plano de saúde, o qual deve lhe garantir acesso amplo e seguro à assistência à saúde.

Logo, considerando a gravidade da enfermidade que acomete a parte autora, não se mostra minimamente razoável limitar as alternativas terapêuticas disponíveis para o seu tratamento às listadas em protocolo que historicamente não consegue acompanhar a velocidade dos avanços da medicina, o que, caso ocorresse, configuraria efetiva negativa de adequado tratamento à parte autora, expondo-a a risco de dano irreparável a sua saúde.

Ademais, descabida a alegação do demandado de que o fornecimento da prestação de saúde, por não estar previsto nas suas tabelas vigentes à época, implicaria sobrecarga ou mesmo comprometimento do orçamento da autarquia destinado à saúde, porquanto eventual negativa, nessas circunstâncias, só poderia ocorrer com base em contestação técnica médica suficiente.

Não há prova alguma no processo que evidencie qualquer impedimento ao cumprimento da determinação judicial pelo demandado. Outrossim, a autarquia não se desincumbiu de provar que o tratamento indicado pelo médico assistente acarretaria oneração desnecessária para o Instituto.

Com efeito, em que pese a medicação solicitada não constasse nas tabelas de cobertura da autarquia, não há que se falar em ilegalidade da pretensão da parte autora, tampouco em afronta aos princípios da isonomia e da igualdade. Neste sentido:

> *APELAÇÃO CÍVEL. IPE-SAÚDE. PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE NEOPLASIA DE COLO UTERINO (CID 10 C53).* ***NEGATIVA DE COBERTURA ADMINISTRATIVA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CALCADA NA AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. EXEGESE DO ART. 4º DA LEI COMPLEMENTAR N.º 15.145/2018. SUFICIÊNCIA DO LAUDO MÉDICO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E ISONOMIA. INOCORRÊNCIA.*** *MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. 1. Conforme preconiza o artigo 4º da Lei Complementar n.º 15.145/2018, aplicável ao caso em análise, o Plano IPE-SAÚDE é integrado pelos atendimentos médicos, hospitalares, envolvendo os atos necessários ao diagnóstico e ao tratamento, bem como ações de prevenção da doença e à promoção da saúde. Inegável, assim, a responsabilidade de custeio integral do fármaco ora postulado. 2.* ***A escolha do medicamento e do tipo de tratamento a ser concedido ao paciente cabe ao médico e não ao convênio, já que somente o profissional especializado é quem poderá optar e recomendar qual o melhor método e/ou material a ser utilizado em cada caso, tudo no objetivo de alcançar o melhor resultado.*** *3. Não merece guarida o apelo do IPE Saúde quanto à pretensão de redução da verba honorária sucumbencial. Com efeito, os honorários de sucumbência fixados em favor do patrono da parte autora observaram os parâmetros razoáveis, estando em conformidade com o disposto no art. 85, §§2º e 8º, do CPC/15. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, Nº 50004065020158210130, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 25-05-2022) [grifos nossos].*

Dessa maneira, evidenciado o direito ao fornecimento do medicamento postulado ao tratamento de sua patologia, imperioso o julgamento procedente da ação.

Diante do exposto, **JULGO PROCEDENTES** os pedidos formulados por LORI MARQUES BONES em face do IPE-SAÚDE, tornando definitiva a decisão que deferiu a tutela de urgência, determinando o fornecimento do medicamento **Ruxolitinibe,** na dosagem e periodicidade determinadas pela médica assistente, e por tempo indeterminado.

Isento o demandado do pagamento da **Taxa Única de Serviços Judiciais**, consoante o previsto no artigo 5º, inciso I, da Lei nº 14.634/14.

Condeno o demandado ao pagamento das **despesas processuais NÃO ABRANGIDAS PELA TAXA ÚNICA** (artigos 14 e seguintes da Lei nº 14.634/2014, e artigo 84 do CPC), bem como ao **ressarcimento** à parte autora das **custas** processuais adiantadas e ao pagamento de **honorários sucumbenciais** ao procurador da parte autora, que fixo em R$ 2.000,00, nos termos do artigo 85, §8º, do CPC.

Em conformidade ao artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, o valor dos honorários deverá ser atualizado monetariamente pela Taxa Selic a contar da data da sua fixação; com incidência de juros moratórios, segundo o mesmo índice da Taxa Selic, a contar do trânsito em julgado, conforme artigo 85, §16, do CPC.

Sentença registrada e publicada eletronicamente, da qual vão as partes intimadas via sistema Eproc.

Interposta apelação, processe-se, conforme os trâmites legais e, após, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça.

Havendo saldo vinculado ao feito, expeça-se alvará a quem de direito.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e procedam-se com os **atos ordinários necessários** à cobrança de eventuais despesas processuais: expedição de RPV, intimações, alvarás para destinação dos valores e demais atos.

Consigno que, após o trânsito em julgado da sentença, nos termos do Ofício-Circular nº 077/2019-CGJ, o cumprimento de sentença deverá tramitar com novo número de processo no Eproc, incumbindo ao exequente distribuí-lo em autos apartados, vinculando o número do processo de conhecimento e recolhendo as custas correspondentes, se for o caso.

Por fim, baixe-se.

Documento assinado eletronicamente por **LETICIA MICHELON, Juíza de Direito**, em 12/05/2025, às 18:54:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10082331737v4** e o código CRC **ae3c3089**.